Classification TIM

Dr.A.L.2026

INTRODUCTION

• J'ai préparé ce PDF comme un petit compagnon de route pour réviser les différentes classifications TNM présentes au programme de médecine, de la 4e à la 6e année.

• J'ai essayé, autant que possible, de me baser sur les dernières recommandations et les éditions les plus récentes, afin d'en faire un document pratique, clair et surtout utile pour nos révisions.

• C'est un document que j'ai initialement préparé pour moi-même, avec l'envie d'y rassembler l'essentiel, les points importants à retenir, ainsi que certaines notions qui sont déjà tombées au concours de spécialité. J'ai également ajouté quelques petites remarques personnelles qui, je l'espère, pourront vous être utiles.

• Je souhaite surtout qu'il reste un outil de partage. Je ne vous dirai donc pas de ne pas le diffuser, bien au contraire : je ne voudrais pas que ce fichier soit réservé à quelques personnes. S'il arrive entre vos mains et qu'il peut aider quelqu'un d'autre à mieux comprendre, mémoriser ou réviser, alors partagez-le sans hésiter.

• Qu'il circule, qu'il soit annoté, corrigé, enrichi et amélioré. Vous avez toute liberté d'y ajouter ce que vous jugez pertinent, car un document destiné à l'apprentissage n'est jamais vraiment terminé : il grandit avec chaque nouvelle connaissance qu'on y dépose.

• J'espère simplement qu'un jour, quelque part, ce petit fichier pourra tomber au bon moment entre les mains de quelqu'un qui en avait besoin. Et si une seule personne trouve grâce à lui une information qui lui manquait, quelques minutes de révision plus faciles ou une réponse juste le jour du concours, alors tout le travail derrière ces pages aura déjà trouvé son sens. 🤍

• Je vous souhaite beaucoup de courage dans vos révisions, de la constance dans vos efforts et, surtout, que toutes ces longues journées finissent par vous mener exactement là où vous rêvez d'être.

« Bon courage à tous, et qu'Allah vous accorde la réussite et vous permette de voir se réaliser chacun de vos souhaits »

Dr. A. L

— = QST résidanat

— = QST EXTERNAT

: notion importante

—: notion de plus

Kc de l'œsophage

3ème Kc digestif (après le CCR et le Kc gastrique)

- Classification TNM (2017) :

T0	Pas de signe de tumeur primitive
Tis	Carcinome *in situ* ou dysplasie de haut grade
T1	Tumeur envahissant la lamina propria, la muscularis mucosae ou la sous-muqueuse
T1a	La tumeur envahit la lamina propria ou la muscularis mucosae
T1b	La tumeur envahit la sous-muqueuse
T2	Tumeur envahissant la musculeuse
T3	Tumeur envahissant l'adventice
T4	Tumeur envahissant les structures adjacentes
T4a	La tumeur envahit la plèvre, le péricarde, la veine azygos, le diaphragme ou le péritoine
T4b	La tumeur envahit d'autres structures adjacentes comme l'aorte, un corps vertébral ou la trachée.

NX	Le statut des ganglions régionaux ne peut être évalué
N0	Pas de signe d'atteinte des ganglions lymphatiques régionaux
N1	Métastases dans 1 à 2 ganglions lymphatiques régionaux
N2	Métastases dans 3 à 6 ganglions lymphatiques régionaux
N3	Métastases dans 7 ganglions régionaux ou plus
pN0	L'examen histologique d'une pièce opératoire de lymphadénectomie incluera habituellement 6 ganglions lymphatiques ou plus. Classer pN0 même si le nombre préconisé de ganglions réséqués n'est pas atteint.

Les adénopathies cervicales, thoraciques et abdominales supérieures, y compris cœliaques, sont considérées comme régionales. Seules les adénopathies sus-claviculaires et les adénopathies lombo-aortiques sont considérées comme métastatiques.

M0	Pas de métastase à distance
M1	Présence de métastase(s) à distance

Symbole c : le signe TNM ou cTNM correspond à la classification clinique pré-thérapeutique, résultat de l'examen clinique, de l'imagerie, de l'endoscopie, des biopsies et des autres examens complémentaires.

Symbole y : dans tous les cas où la classification est effectuée durant ou après traitement néo-adjuvant, le cTNM ou le pTNM est précédé du préfixe y.

Symbole p : le pTNM correspond à la classification histologique postopératoire, complétée ou modifiée par les observations supplémentaires recueillies au cours de l'acte chirurgical et de l'examen histopathologique.

Stade 0	Tis	N0	M0
Stade IA	T1a	N0	M0
Stade IB	T1b	N0	M0
	T2	N0	M0
Stade II	T1	N1	M0
	T3	N0	M0
Stade IIIA	T1	N2	M0
	T2	N1	M0
	T2	N2	M0
Stade IIIB	T3	N1,N2	M0
	T4a	N0,N1	M0
	T4a	N2	M0
Stade IVA	T4b	Tous N	M0
	Tous T	N3	M0
Stade IVB	Tous T	Tous N	M1

Carcinome épidermoide

Stade 0	Tis	N0	M0
Stade IA	T1a	N0	M0
Stade IB	T1b	N0	M0
Stade IIA	T2	N0	M0
Stade IIB	T1	N1	M0
	T3	N0	M0
Stade IIIA	T1	N2	M0
	T2	N1	M0
Stade IIIB	T2	N2	M0
	T3	N1, N2	M0
	T4a	N0, N1	M0
Stade IVA	T4a	N2	M0
	T4b	Tous N	M0
	Tous T	N3	M0
Stade IVB	Tous T	Tous N	M1

Adénocarcinome

Presque, c'est la même chose et la même classification entre cancer de l'estomac et cancer œsophagienne. Au contraire, on va voir un petit changement au niveau de la classification du cancer du colon dans N2 avec un ganglions de plus pour dire classé N2

Kc de l'estomac

- Classification TNM (2016) :

T : Tis : Tumeur intra-épithéliale sans invasion de la *lamina propria*, dysplasie de haut grade
T1 : Tumeur limitée à la muqueuse ou à la sous-muqueuse (cancer superficiel)
T1a : Tumeur envahissant la *lamina propria* ou la musculaire muqueuse
T1b : Tumeur envahissant la sous muqueuse
T2 : Tumeur étendue à la musculeuse
T3 : Tumeur envahissant la sous séreuse (y compris ligament gastro-colique ou gastro-hépatique ou grand épiploon)
T4 : Tumeur envahissant la séreuse ou les organes adjacents
T4a : Tumeur envahissant la séreuse (péritoine viscéral)
T4b : Tumeur envahissant un organe ou une structure de voisinage (rate, côlon transverse, foie, diaphragme, pancréas, paroi abdominale, surrénale, rein, intestin grêle, rétropéritoine)
L'envahissement de l'œsophage ou du duodénum n'est pas considéré comme l'envahissement d'un organe adjacent.

N : Nx : ganglions non évaluables
N0 : pas d'envahissement ganglionnaire (noter combien de ganglions ont été examinés)
N1 : 1 à 2 ganglions régionaux métastatiques
N2 : 3 à 6 ganglions régionaux métastatiques
N3 : 7 ou plus ganglions régionaux métastatiques
N3 a : 7 à 15 ganglions régionaux métastatiques
N3b : 16 ou plus ganglions régionaux métastatiques

M : M0 : pas de métastase
M1 : métastase à distance (dont ganglions rétro-pancréatiques, mésentériques, para-aortiques, sus-claviculaires)

Stade 0	Tis	N0	M0
Stade IA	T1	N0	M0
Stade IB	T1	N1	M0
	T2	N0	M0
Stade IIA	T1	N2	M0
	T2	N1	M0
	T3	N0	M0
Stade IIB	T1	N3a	M0
	T2	N2	M0
	T3	N1	M0
	T4a	N0	M0
Stade IIIA	T2	N3a	M0
	T3	N2	M0
	T4a	N1, N2	M0
	T4b	N0	M0
Stade IIIB	T1	N3b	M0
	T2	N3b	M0
	T3	N3a	M0
	T4a	N3a	M0
	T4b	N1, N2	M0
Stade IIIC	T3	N3b	M0
	T4a	N3b	M0
	T4b	N3a, N3b	M0
Stade IV	Tout T	Tout N	M1

Cancer du colon et rectum

- Classification TNM (2017) :

Tis : carcinome intra-épithélial ou intra-muqueux (Carcinome *in situ*,adénocarcinome intra-muqueux envahissant le chorion ou la musculaire muqueuse).

T1 : tumeur envahissant la sous-muqueuse

T2 : tumeur envahissant la musculeuse

T3 : tumeur envahissant la sous-séreuse

T4 : tumeur pénétrant le péritoine viscéral et/ou envahissant au moins une structure/organe de voisinage
- T4a : pénétration du péritoine viscéral*
- T4b : envahissement d'une structure de voisinage**

N0 : pas de métastase ganglionnaire régionale

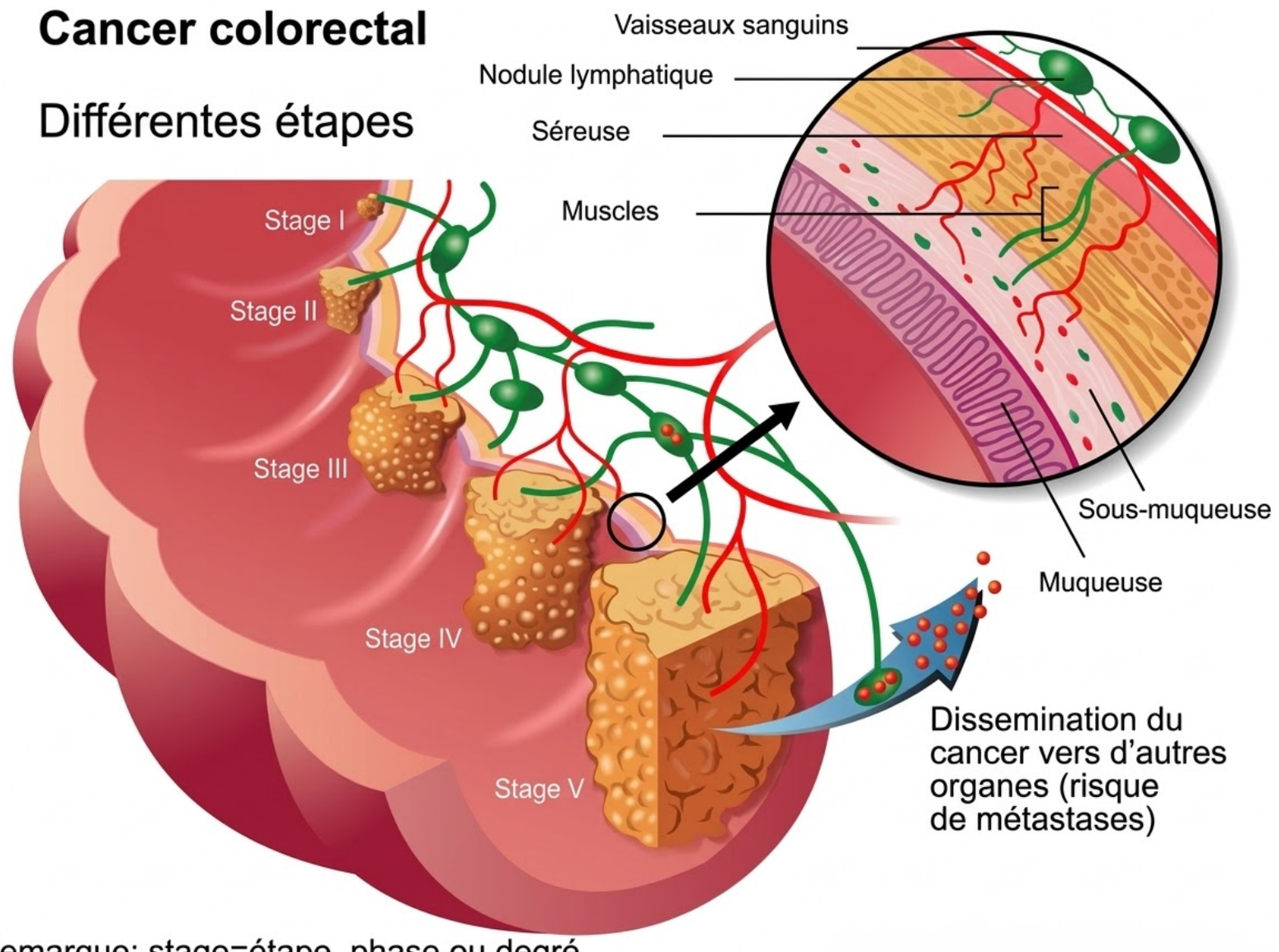
N1 : métastase dans 1 à 3 ganglions lymphatiques régionaux***
- N1a : métastase dans 1 ganglion lymphatique régional
- N1b : métastases dans 2-3 ganglions lymphatiques régionaux
- N1c : dépôts tumoraux « satellites » dans la sous-séreuse, ou dans le tissu péri-colique ou péri-rectal non péritonisé, en l'absence de ganglion métastatique****

N2 : métastase ≥4 ganglions lymphatiques régionaux
- N2a : métastase dans 4-6 ganglions lymphatiques régionaux
- N2b : métastase dans ≥ 7 ganglions lymphatiques régionaux

M0 : pas de métastase à distance
- M1a : métastases à distance confinées à un organe sans atteinte péritonéale : foie, poumon, ovaire, ganglions non régionaux …
- M1b : métastases atteignant plus d'un site métastatique
- M1c : métastase péritonéale avec ou sans autre organe atteint

Stade	Survie à 5 ans(%)	Récidive(%)
I	90	16
II	60	32
III	36	59
IV	3	97

Stade 0	pTis N0 M0
Stade I	pT1-2 N0 M0
Stade IIA	pT3 N0 M0
Stade IIB	pT4a N0 M0
Stade IIC	pT4b N0 M0
Stade IIIA	pT1-T2 N1/N1c M0 et pT1 N2a M0
Stade IIIB Qst R	pT3-T4a N1N1c M0, pT2-T3 N2a M0, pT1-T2 N2b M0
Stade IIIC	pT4a N2a M0; p T3-T4a N2b M0; pT4b N1-N2 M0
Stade IVA	tout T, tout N, M1a
Stade IVB	tout T, tout N, M1b
Stade IVC	tout T, tout N, M1c



Remarque: stage=étape, phase ou degré

GYNÉCOLOGIE

Kc sein

TNM			Description
Taille	T0		Tumeur non palpable.
	Tis		Carcinome in-situ
	T1	T1mic	≤ 0.1 cm
	≤ 2 cm	T1a	> 0.1 cm et ≤ 0.5 cm
		T1b	> 0.5 cm et ≤ 1 cm
		T1c	> 1 cm et ≤ 2 cm
	T2		> 2 cm et ≤ 5 cm
	T3		> 5 cm
	T4	T4a	Extension à la paroi thoracique
		T4b	Extension à la peau
		T4c	Extension à la peau et à la paroi thoracique
		T4d	Tumeur inflammatoire
Nodes	N0		Absence de signes d'envahissement ganglionnaire
	N1		Ganglions axillaires homolatéraux suspects mobiles
	N2	N2a	Ganglions axillaires homolatéraux fixes
		N2b	Ganglions mammaires internes homolatéraux sans ADP axillaires
	N3	N3a	Ganglions suspects sous-claviculaires et axillaires homolatéraux
		N3b	Ganglions mammaires internes et axillaires homolatéraux
		N3c	Ganglions suspects sus-claviculaires
Metastases	M0		Pas de métastases retrouvées
	M1		Métastases

Cancer du sein

Mais selon mon point de vue, ce petit résumé est suffisant pour répondre aux questions.

TNM

T1 = ≤ 2 cm (R) **T2 = 2 à 5 cm** **T3 = > 5 cm**
T4a : paroi thoracique (hors pectoral)
T4b : œdème (dont peau d'orange) ou ulcération cutanée ou nodule de perméation sur la peau
T4c : 4a + 4b
T4d : cancer inflammatoire

N1mi : micro-métastase > 0,2 mm et ≤ 2 mm
N1 : c = ADP axillaire mobile p = 1 à 3 ADP axillaire
N2 : c = ADP axillaire fixée p = 4 à 9 ADP axillaire
N3 : c = ADP mammaire interne p = ≥ 10 ADP axillaire ou ≥ 1 ADP sous-clavière
M1 = métastase (y compris ADP sus-claviculaire)

Généralement, il n'y a pas de questions directes ; ces notions se retrouvent plutôt dans l'énoncé, juste pour mieux comprendre les choses.

Grading SBR (Scarff-Bloom-Richardson) modifié par Elston et Ellis

1. Différenciation tubulo-glandulaire : proportion de tubes ou glandes dans la tumeur (en % de surface tumorale)	Score
>75 % : tumeur bien différenciée	1
10 à 75 % : tumeur moyennement différenciée	2
<10 % : tumeur peu différenciée	3
2. Pléomorphisme nucléaire : degré d'atypie apprécié sur la population tumorale prédominante	
Noyaux petits, réguliers, uniformes	1
Pléomorphisme modéré	2
Variations marquées de taille, de forme, avec nucléoles proéminents	3
Nombre de mitoses (à compter sur 10 champs au grossissement x400 ; valeurs définies pour un champ de 0,48 mm de diamètre ; calibrage du microscope nécessaire pour des champs différents)	
0 à 6 mitoses	1
7 à 12 mitoses	2
>12 mitoses	3
AU TOTAL	
Grade I	3 ou 4 ou 5
Grade II	6 ou 7
Grade III	8 ou 9



A SAVOIR ➪ LA CLASSIFICATION BI-RADS (BREAST IMAGING-REPORTING AND DATA SYSTEM) DE L'AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY (ACR)

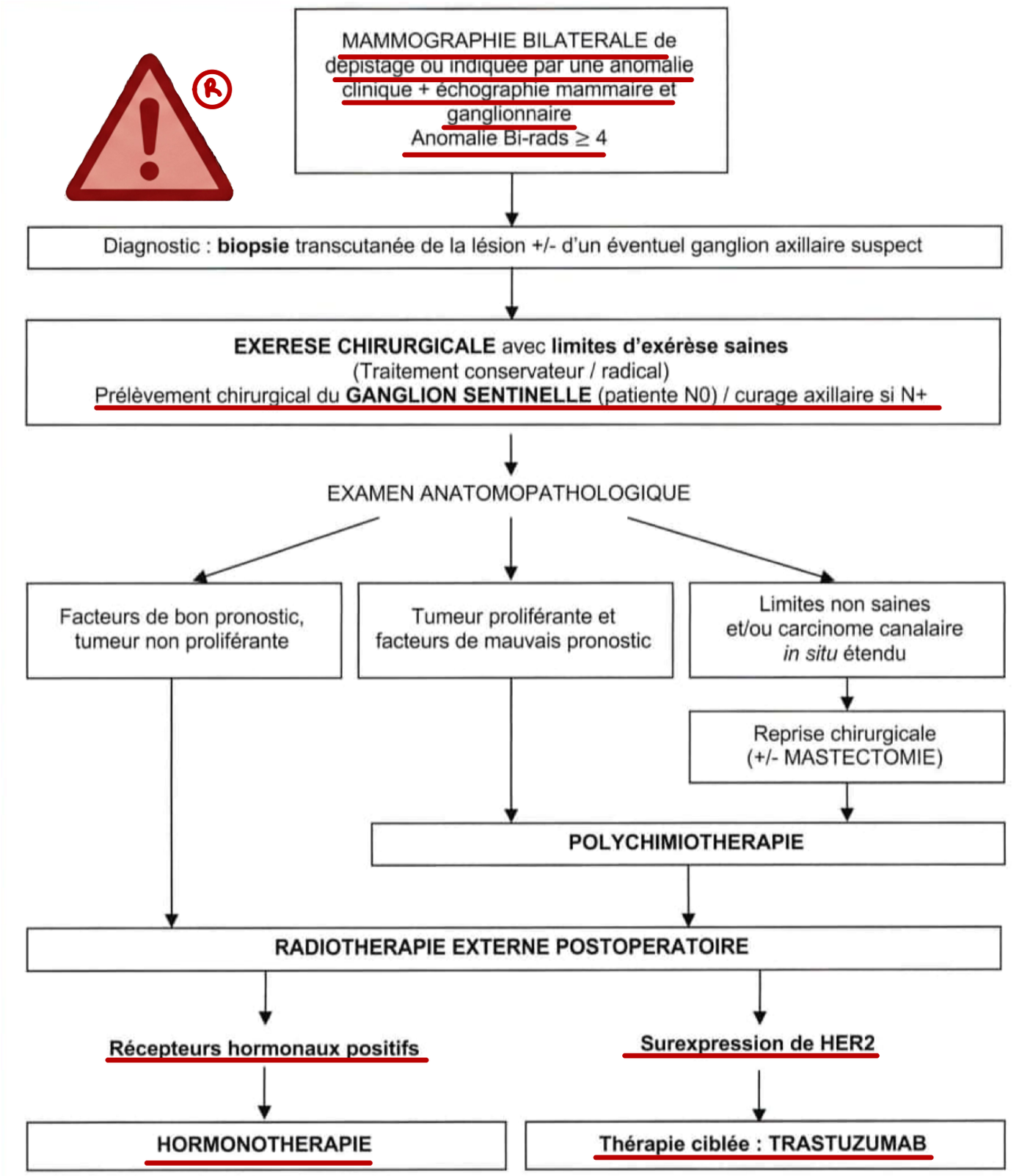
Les radiologues classent les images mammographiques en 7 catégories : BI-RADS 1 (mammographie normale) à BI-RADS 5 (images d'allure malignes) ; ACR 0 lorsqu'on ne peut rien conclure de l'examen ; BI-RADS 6 lorsqu'on a la preuve histologique de la malignité.

Catégorie	Interprétation	Risque de cancer	Conduite à tenir
0	Investigation incomplète		Investigation à compléter
1	Mammographie normale	0	Retour au dépistage / suivi normal
2	Anomalie bénigne	0	Retour au dépistage / suivi normal
3	Anomalie probablement bénigne	< 2 %	Surveillance à 4/6 mois ou biopsie d'emblée
4	Anomalie suspecte	2 à 90 %	Biopsie
(R) 5	Anomalie évocatrice d'un cancer	> 90 %	Biopsie
6	Cancer prouvé histologiquement	100 %	Traitement

GYNÉCOLOGIE

Dans d'autres sources, on peut trouver comme repère 20 %

Groupe	RO	RP	HER2	Ki67	Réponse aux traitements	Pronostic
Luminal A	+	+	-	< 14%	Bonne réponse à l'hormonothérapie	Favorable
Luminal B	+	+	+	> 14%	Réponse variable à l'hormonothérapie, meilleure réponse à la chimiothérapie	Plus sévère que Luminal A
HER2	-	-	+++	-	Réponse au Trastuzumab (anti-HER2) et aux anthracyclines	Défavorable
Triple négatif	-	-	-	Élevé	Chimiothérapie systématique	Très défavorable

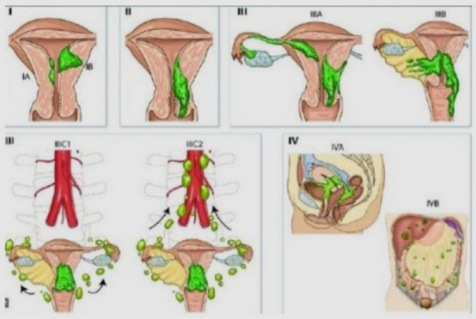


GYNÉCOLOGIE

Kc de l'endomètre

♣ Classification FIGO :

Classification FIGO		
Stade I	Survie à 5 ans 85%	= Limité au corps utérin (± glandes cervicales) : sans atteinte du col utérin - **IA** = envahissement du myomètre **< 50%** ® - **IB** = envahissement du myomètre **≥ 50%** **Sans att de stroma** ®
Stade II	66%	= Atteinte du col utérin sans atteinte extra-utérine associée Avec att de stroma
Stade III	44% ®	= Extension extra-utérine : - **IIIA** = séreuse du corps utérin et/ou annexes - **IIIB** = vagin et/ou paramètre - **IIIC** = envahissement ganglionnaire pelvien (c1) ou para-aortique (c2)
Stade IV	15%	- **IVA** : atteinte de la muqueuse vésicale et/ou rectale - **IVB** : ADP ganglionnaire inguinale et/ou MT à distance



® • Stade IA (ADK endométrioïde) + risque bas (cellules indifférenciées < 5%) → hystérectomie totale avec annexectomie sans traitement adjuvant
• Stade IA (ADK endométrioïde) + risque intermédiaire (cellules indifférenciées > 50%) → hystérectomie + curage pelvien + curiethérapie post-opératoire
• Stade IA à risque élevé (> 50%), Stade IB, stade II ou IIIA (séreuse du corps utérin et/ou annexes) → hystérectomie totale avec annexectomie + curage pelvien et lombo-aortique + cytologie et biopsies péritonéales + omentectomie infra-colique, radiothérapie post-op, curiethérapie, chimiothérapie adjuvante
• Stade IIIb et c → curage lombo-aortique + radiothérapie externe + curiethérapie ± chimiothérapie adjuvante
• Stade I, II, IIIA (séreuse du corps utérin et/ou annexes)

Par voie vaginale, c'est on a une absence d'extension au vagin

Kc de l'ovaire

Stade I	**Limitée aux ovaires** (1 ou les 2)	☞ IA : tumeur limitée à **1 ovaire** , sans tumeur visible à la surface, capsule intact et cytologie péritonéale (-) ® ☞ IB : tumeur des **2 ovaires**, sans tumeur visible à la surface, capsule intact et cytologie péritonéale (-) ☞ IC : 1 ou 2 ovaires avec **rupture capsulaire per-opératoire (IC1), rupture pré-opératoire** ou **tumeur à la surface d'un ovaire (IC2)** ou **cytologie péritonéale (+) (IC3)**
Stade II	**Extension pelvienne**	☞ IIA : **Utérus** et/ou **trompe** + cytologie péritonéale (-) ☞ IIB : **autres organes pelviens** + cytologie péritonéale (-) ☞ IIC : **atteinte pelvienne + cytologie péritonéale (+)**
Stade III	**Extension péritonéale abdominale** et/ou **ADP rétropéritonéale**	☞ IIIA : **ADP rétropéritonéale** (IIIA1) et/ou **atteinte microscopique extra-pelvienne** (IIIA2) ☞ IIIB : atteinte macroscopique extra-pelvienne ≤ 2 cm ± ADP ☞ IIIC : atteinte macroscopique extra-pelvienne >2 cm ± ADP
Stade IV	**Métastase à distance (autre que péritonéale)** : hépatiques ou spléniques, extra-abdo (dont ADP inguinale ou ADP extra-abdominale)	

Notion de résidanat :
Les tumeurs ovariennes borderline (tumeurs à la limite de la malignité) de stade I sans implants invasifs ont une chimiosensibilité nulle ; la chimiothérapie adjuvante est formellement inutile et non indiquée (CNGOF / Guides Thérapeutiques en Oncologie Médicale 2026).

Kc de col utérin

Classification FIGO		
Stade I	**90%** de survie à 5 ans	= Limité au col : - IA = **micro-invasif** : - **IA1** : envahissement du chorion ≤ 3 mm, largeur ≤ 7 mm - **IA2** : envahissement du chorion > 3 mm, largeur > 7 mm ® - IB = **cancer invasif** = cancer cliniquement visible : - **IB1** : **≤ 4 cm** - **IB2** : **> 4 cm**
Stade II	**75%** de survie à 5 ans	= Dépasse le col sans atteindre la paroi pelvienne ou le 1/3 inférieur du vagin - IIA = absence d'atteinte paramétriale : ≤ 4 cm (IIA1) ou > 4 cm (IIA2) - IIB = atteinte paramétriale
Stade III	**60%** de survie à 5 ans	= Atteinte du 1/3 inférieur du vagin et/ou de la paroi pelvienne et/ou ADP pelvienne - IIIA = 1/3 inférieur du vagin sans atteinte pelvienne - IIIB = - Atteinte de la paroi pelvienne et/ou Hydronéphrose/rein muet et/ou Atteinte ganglionnaire pelvienne
Stade IV	**35%** de survie à 5 ans	- IVA : atteinte de la muqueuse vésicale ou rectale - IVB : extension extra-pelvienne

Trt de IB : ® Curiethérapie + colpo-hystérectomie élargie + radiothérapie si ganglions positifs.

Kc bronchiques

CLASSIFICATION TNM 9ème EDITION

Samedi pédagogique 2026
une nouvelle édition

1. Classification TNM 9ème édition (1–3)

La 8ème classification TNM, en vigueur jusqu'en 2025, reste consultable en ANNEXE 2.

T – Tumeur (plus grande dimension)	**Tx**	Tumeur primitive non évaluable ou tumeur prouvée par la présence de cellules malignes dans les sécrétions broncho-pulmonaires mais non visible aux examens radiologiques et endoscopiques.
	T0	Absence de tumeur identifiable
	Tis	Carcinome *in situ*.
	T1	Tumeur de **3 cm ou moins** (≤3cm) dans ses plus grandes dimensions, entourée par du poumon ou de la plèvre viscérale, sans évidence d'invasion plus proximale que les bronches lobaires à la bronchoscopie (c'est-à-dire pas dans les bronches souches).
	T1mi	Adénocarcinome à invasion minime.
	T1a	≤ 1cm
	T1b	> 1 cm et ≤ 2 cm
	T1c	> 2 cm et ≤ 3 cm
	T2	Tumeur avec quelconque des éléments suivants :
	T2a	-Tumeur de plus de 3 cm (>3cm), mais de moins de 4 cm (≤4cm) -Envahissement de la plèvre viscérale, -Envahissement d'un lobe adjacent, -Envahissement d'une bronche souche (quelle que soit sa distance par rapport à la carène mais sans envahissement de la carène) ou associé à une atélectasie ou une pneumonie obstructive étendue à la région hilaire, touchant n'importe quelle partie du poumon dans sa globalité.
	T2b	Tumeur de plus de 4 cm (>4cm), mais de moins de 5 cm (≤5cm) (R)
	T3	Tumeur avec quelconque des éléments suivants : -Tumeur de **plus de 5 cm (>5cm) et de moins de 7 cm (≤7cm)**, -Associée à un**(des) nodule(s) tumoral(aux) distinct(s) dans le même lobe**, -Envahissant directement : • La paroi thoracique, la plèvre pariétale, le péricarde, le nerf phrénique, la veine azygos, • Les racines nerveuses thoraciques (i.e. T1, T2), le ganglion stellaire.
	T4	Tumeur avec quelconque des éléments suivants : -Tumeur de **plus de 7 cm** (>7cm) -Associée à des nodules tumoraux séparés dans deux lobes différents du même poumon, -Envahissant directement : • Le cœur ou les gros vaisseaux (aorte, veine cave supérieure/inférieure, veines et artères pulmonaires intra-péricardiques), les artères supra-aortiques, les veines brachiocéphaliques, • Le médiastin, le thymus, la trachée ou la carène, le diaphragme, le nerf récurrent, le nerf vague, l'œsophage, • Les vaisseaux sous-claviers, un(des) corps vertébral(aux), le mur postérieur vertébral (lamina), le canal médullaire, les racines nerveuses cervicales, ou le plexus brachial. • Un(des) corps vertébral(ux).
N - Adénopathies	**N0**	Absence de métastase dans les ganglions lymphatiques régionaux.
	N1	Métastase(s) ganglionnaire(s) péri-bronchique(s) homolatérale(s) et/ou hilaire(s) homolatérale(s) et/ou intrapulmonaire(s) homolatérale(s) incluant une extension directe.
	N2	Métastase(s) dans les ganglions médiastinaux homolatéraux et/ou dans les ganglions sous-carénaires
SP!	**N2a**	Atteinte d'une seule station N2
SP!	**N2b**	Atteinte de multiples stations N2
	N3	Métastase(s) ganglionnaire(s) médiastinale(s) controlatérale(s) ou hilaire(s) controlatérale(s) ou scalénique(s), sus-claviculaire(s) homo- ou controlatérale(s).
Métastases	**M0**	Pas de métastase à distance.
	M1	Existence de métastases :
	M1a	Nodule(s) tumoral(ux) séparés dans un lobe controlatéral, ou nodules pleuraux ou pleurésie maligne ou péricardite maligne
	M1b	Une seule métastase extra-thoracique dans un seul système organe[A]
SP!	**M1c1**	Multiples métastases extra-thoracique dans UN SEUL système d'organes
	M1c2	Multiples métastases extra-thoracique dans de MULTIPLES systèmes d'organes

PNEUMOLOGIE

	N0	N1	N2a	N2b	N3	M1a-b *Tout N*	M1c1 *Tout N*	M1c2 *Tout N*
T1a	IA-1	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV-A	IV-B	IV-B
T1b	IA-2	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV-A	IV-B	IV-B
T1c	IA-3	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV-A	IV-B	IV-B
T2a	IB	IIB	IIIA	IIIB	IIIB	IV-A	IV-B	IV-B
T2b	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IIIB	IV-A	IV-B	IV-B
T3	IIB	IIIA	IIIA	IIIB	IIIC	IV-A	IV-B	IV-B
T4	IIIA	IIIA	IIIB	IIIB	IIIC	IV-A	IV-B	IV-B

Pour la pratique on retiendra 4 grandes situations

- Cancers localisés (stades I et II) :
  traitement local (chirurgie à défaut radiothérapie si inopérable)
- Cancers localement avancés éventuellement chirurgicaux (stades IIIa) :
  traitement systémique (chimiothérapie) + traitement local (radiothérapie ou chirurgie).
- Cancers localement avancés non chirurgicaux (stades IIIb et IIIc) :
  traitement systémique (chimiothérapie) + traitement local (radiothérapie).
- Cancers disséminés (stades IV) :
  traitement systémique (chimiothérapie ou thérapie ciblée en 1ère ligne)

Classification de CPC

cancer a ptt cellule

La chimiothérapie est le traitement de référence du CBPC qui souvent très chimiosensible ; Le doublet de référence : cisplatine et étoposide
En pratique, on distingue 2 situations :

➢ CPC localisés au thorax: quand la tumeur peut être incluse avec ses adénopathies satellites (homo, controlatérales et sus claviculaires homolatérales) dans un même champ d'irradiation et pour lesquelles, une radiothérapie thoracique peut être proposée.
➢ Cpc étendus ou diffus : en présence d'une pleurésie ou péricardite néoplasique ou d'une métastase à distance.

Cancer du cavum

TNM			
T	Tis	carcinome in situ	
	T1	Extension vers les parties molles de l'**oropharynx** et/ou **fosse nasale**	
	T2	tumeur avec extension **parapharyngée**	
	T3	Envahissement des structures **osseuses**, de la **base du crâne** et/ou **sinus maxillaires**	
	T4	Extension **endocrânienne** et/ou atteinte des **nerfs crâniens** de l'hypopharynx , de l'orbite ou extension à la **fosse sous-temporale /espace masticateur.**	
N	N1	**ADP unilatérale** cervicale < 6 cm , et ou retropharyngiées , au dessus de la clavicule.	
	N2	**ADP bilatérales** dont le diamètre < 6 cm , dessus de la clavicule (bord inf circoide)	
	N3	N3a	ADP > 6cm
		N3b	ADP dans les creux sus claviculaires
M	M0	pas de métastases	
	M1	présence de métastases	

- stade I = N0
- stade II = N1 et T2
- stade III = N2 et T3
- stade IV = T4 et M1

Cancer de l'amygdale

T1: tumeur – de 2 cm Qst R

T2: tumeur entre 2cm et 4 cm

T3: tumeur sup ou égale à 4 cm mais reste limitée à l'oropharynx

T4: tumeur dépassant les limites de l'oropharynx étendue a l'os ;muscles, peau

N0: pas d'ADP

N1: Gg(ganglion) homolatéral unique inferieur à 3 cm Qst R

N2a : Gg unique homolatéral entre 3 et 6 cm

N2b: Gg multiples homolatérales inferieur à 6cm

N2c: Gg multiples bilatéral ou controlatéral inferieur à 6cm

N 3: Gg supérieur à 6cm

M0: pas de métastase

M1: avec métastase

Stades:
STADE 1: T1 N0 M0
STADE 2: T2 N0 M0
STADE 3: T3 N0 M0 ou T1 ; T2 N1 M0
STADE 4: T4 N0 M0 ou N2 ou M1

Cancer de la Langue

- T1 : Tm < 2cm ne de dépassant pas la ligne médiane
- T2 : Tm 2-4cm ne de dépassant pas la ligne médiane
- T3 : Tm > 4cm dépassant pas la ligne médiane
- T4 : Tm étendue aux organes de voisinage
- N1 : ADP unique homolatérale < 3cm
- N2 : ADP 3-6 cm
  - N2a : unique homolatérale
  - N2b : multiple homolatérale
  - N2c : bilatérale
- N3 : ADP > 6 cm

ENDOCRINOLOGIE

Kc de la thyroïde

Concernant Résidanat :
Il y a deux dossiers qui portent sur le cancer de la thyroïde : l'un sur carcinome de la thyroïde et l'autre sur carcinome médullaire de la thyroïde. Mais il n'y a pas de question sur la classification TNM

Score EU Ti-Rads	Signification	Risque malignité	Conduite à tenir
1	normal		
2	bénin	≈ 0 %	Surveillance standard
3	Risque faible	2 - 4 %	Cytoponction si > 20 mm
4	Risque intermédiaire	6 - 17%	Cytoponction si > 15 mm
5	Risque élevé	26 - 87%	Cytoponction si > 10 mm ***ou*** si < 10 mm et • augmentation de taille • polaire supérieur • au contact de la capsule > 2 mm • multifocal suspecté • < 40 ans

Score Bethesda	Signification	Risque malignité	Conduite à tenir
I	non satisfaisant	?	cytoponction dans 3 à 6 mois
II	bénin	0-3%	échographie dans 6 à 18 mois
III	atypies/ lésions folliculaires de signification indéterminée	5-15%	cytoponction dans 3 à 6 mois
IV	suspicion de néoplasie folliculaire	15-30%	contrôle chirurgical
V	suspicion de cancer	60-75%	contrôle chirurgical
VI	cancer	97-99%	chirurgie chimiothérapie radiothérapie

		pTNM 8ième édition (2017)
T	T1a	T≤1 cm (avec ou sans extension microscopique extrathyroïdienne)
	T1b	1 cm < T ≤ 2 cm (avec ou sans extension microscopique extrathyroïdienne)
	T2	2 cm < T ≤ 4 cm (avec ou sans extension microscopique extrathyroïdienne)
	T3	T3a: T> 4 cm (avec ou sans extension microscopique extrathyroïdienne)
		T3b: T> 4 cm (avec extension maroscopique aux muscles périthyroïdiens (sternocleïdo- , thyro- sterno- omo-hyoïdien)
	T4a	Quel que soit la taille ave extension extrathyroïdienne et invasion des tissus mous sous-cutanés, ou du larynx, ou de la trachée, ou de l'oesophage ou du nerf récurrent
	T4b	Quel que soit la taille ave extension extrathyroïdienne et invasion du fascia prévertébral, de la carotide ou des vaisseaux médiastinaux
N	N0	Pas d'envahissement ganglionnaire
	Nx	Statut ganglionnaire inconnu
	N1a	Envahissement ganglionnaire secteur VI ou médiastinal supérieur (VII)
	N1b	Envahissement ganglionnaire secteur latéral ou rétropharyngé
M	M0	Pas de métastase à distance
	M1	Métastase à distance

	pTNM 8ième édition	(2017)
	< 55 ans	≥ 55 ans
Stade I	tout T, tout N, M0	T1a/T1b/T2, N0, M0
Stade II	tout T, tout N, M1	T3N0M0 T1/T2/T3N1M0
Stade III		T4a, tout N, M0
Stade IV a		T4b, tout N, M0
Stade IV b		Tout T, tout N, M1

Stratification des risques (patients de plus de 45 ans)

Stades	Paramètres	Probabilité de Survie Spécifique à 10 ans
Bas Risque	➢ T< 4 cm ➢ Confinée à la glande	97- 100%
Risque intermédiaire	➢ T > 4cm ➢ EET minime ➢ N+ central (N1a)	85- 95 %
Haut risque	➢ EET macroscopique ➢ N+ latéral (N1b)	50- 70 %
Très haut risque	➢ >55 ans ➢ EET massive (vx) ➢ M+	< 50%

Pacini 2006 Cooper 2009 Haugen 2016

Centre Chirurgie ORL et Thyroïde - Clinique Saint George (Nice)

DERMATOLOGIE

Mélanome

Clinique : lésion mélanocytaire, pigmentée dans 80 à 90% des cas

✓ **≥ 3** critères de la classique **ABCDE** du mélanome :

- **A :** asymétrique
- **B :** bords irréguliers (encoches ou polycycliques)
- **C :** couleur inhomogène (brun, noir marron ou bleu, zone dépigmentée, halo inflammatoire)
- **D :** diamètre > 6 mm (non spécifique)
- **E :** évolution récente documentée (extension en taille, forme, couleur et/ou relief)


Forme irrégulière, non symétrique


Bords irréguliers, non correctement délimités


Couleurs diverses, taches


Modifications (taille, couleur, forme ou épaisseur)

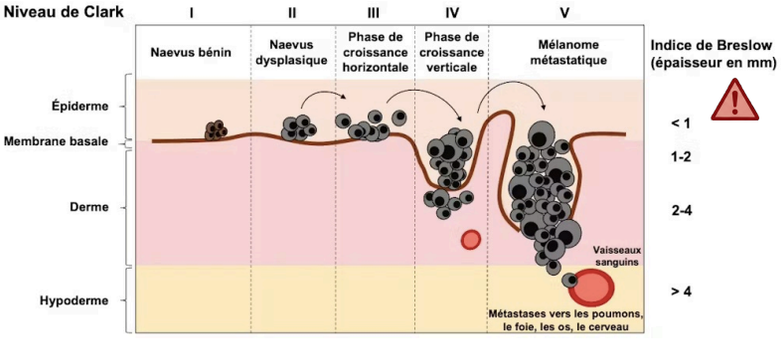
Classification	Epaisseur (mm)	Ulcération/mitoses
T		
Tis	Mélanome in situ	NA
T1	≤ 1	A: sans ulcération et mitoses < 1/mm² B: avec ulcération ou mitoses ≥ 1/mm²
T2	1,01-2	A: sans ulcération B: avec ulcération
T3	2,01-4	A: sans ulcération B: avec ulcération
T4	>4	A: sans ulcération B: avec ulcération

N	Nombre de ganglions métastatiques	Charge métastatique ganglionnaire
N0	0	NA
N1	1	A: micrométastase* B: macrométastase**
N2	2-3	A: micrométastase* B: macrométastase** C: métastases en transit ou satellites sans ganglions métastatiques
N3	≥ 4 ganglions lymphatiques métastatiques ou métastases en transit ou satellites avec ganglions lymphatiques métastatiques	

M	Site	LDH sérique
M0	Pas de métastase à distance	NA
M1a	Métastases à distance de la peau, du tissu sous-cutané ou d'un ganglion	Normal
M1b	Métastases pulmonaires	Normal
M1c	• Toute autre métastase viscérale • Toutes métastases à distance	Normal Elevé

NA: non appliquable; LDH: lactate déshydrogénase; TNM: tumor, node, metastase.
* Les micrométastases sont diagnostiquées avec la technique du ganglion sentinelle.
** Les macrométastases sont définies comme ganglions métastatiques cliniquement décelables et confirmés histologiquement.

Catégorie TNM pour le staging du mélanome cutané (American joint committee on cancer – AJCC, 7e édition, valable dès 1.1.2010)



Notion de plus :

	Carcinome spinocellulaire	Carcinome à cellules de Merkel	Mélanome
Origine cellulaire	Origine épithéliale	Origine épithéliale	Origine crête neurale
Etiologie	UV, HPV	MCV, UV	BRAF, UV, autres
Facteur de risques	• Age >50 ans • Immunosuppression • Peau claire	• Age >50 ans • Immunosuppression • Peau claire	• Age >20 ans • Immunosuppression • Peau claire
Croissance	Lente	Rapide	Lente/rapide
Métastases locales	Rares	Fréquentes	Fréquentes
Métastases lymphatiques	Tardives	Précoces	Précoces
Marqueurs	Kératines (pan/CK5, 6)	Kératines (CK20)	Melan A, S100
Facteur pronostique positif	?	Infiltrat CD8 intratumoral	Infiltrat CD8 intratumoral

TNM: T=taille de la tumeur primaire N=atteinte éventuelle des ganglions lymphatiques («Nodes» en anglais) M=présence éventuelle de métastases; AJCC: American Joint Committee on Cancer.

Tumeur (T)
Tx: la tumeur primaire ne peut être déterminée
T0: absence d'évidence de tumeur primaire (présentation métastatique)
Tis: in situ
T1: dimension maximale de la tumeur ≤2 cm
T2: dimension >2 cm, mais ≤5 cm
T3: >5 cm
T4: invasion locale des structures sous-cutanées (fascia, muscle, cartilage, os)

Ganglions lymphatiques drainants (N=nodes)
Nx: le statut nodal ne peut être investigué
N0: absence de métastase régionale: cN0: évaluation clinique, ultra-sonographique ou radiographique (CT); pN0: absence après évaluation histologique (SLND)
N1: Métastases régionales: N1a: micrométastases; N1b: macrométastases
N2: métastases en transit

Métastases (M)
M0: absence de métastases à distances
M1: métastases: M1a: cutanées, sous-cutanées, ganglions à distance; M1b: pulmonaires; M1c: tout autre site

TNM staging for Merkel Cell Carcinoma (AJCC)

UROLOGIE

Kc de la prostate

Cas clinique dans l'épreuve pathologies de 2020, mais sans la classification

T Tumeur primitive

- TX : tumeur primitive non évaluée
- T0 : tumeur primitive non retrouvée
- T1 : tumeur ni palpable au toucher rectal (TR) ni visible en imagerie
  - T1a : tumeur occupant moins de 5 % du tissu réséqué
  - T1b : tumeur occupant plus de 5 % du tissu réséqué
  - T1c : tumeur découverte sur une biopsie prostatique en raison d'une élévation du taux des PSA.
- La classification de l'American Joint Commitee intègre le score de Gleason pour différencier le T1a du T1b :
  - T1a < 5 % du tissu réséqué avec un score de Gleason < 7 ou absence de grade 4 ou 5.
  - T1b > 5 % du tissu réséqué ou un score de Gleason > 7 ou présence de grade 4 ou 5.
- T2 : tumeur limitée à la prostate
  - T2a : tumeur atteignant la moitié d'un lobe ou moins
  - T2b : tumeur atteignant plus de la moitié d'un lobe mais sans atteindre les deux lobes
  - T2c : tumeur atteignant les deux lobes
- T3 : extension au-delà de la capsule
  - T3a : extension extra-capsulaire uni- ou bilatérale
  - T3b : extension aux vésicules séminales uni- ou bilatérale
- T4 : tumeur fixée ou atteignant d'autres structures que les vésicules séminales (sphincter externe, rectum, muscles releveurs de l'anus ou paroi pelvienne)

N Ganglions régionaux

- NX : ganglions régionaux non évalués
- N0 : absence de métastase ganglionnaire régionale
- N1 : atteinte ganglionnaire régionale
- N1 mi : métastase ganglionnaire < 0,2 cm (optionnel)

Métastases à distance

- MX : métastases à distance non évaluées
- M0 : absence de métastase à distance
- M1 : métastases à distance
- M1a : atteinte des ganglions non régionaux
- M1b : atteinte osseuse
- M1c : autres sites

Classification TNM ADK PROSTATE	Trt
T1 : non palpable et invisible à l'imagerie = découverte fortuite	< 70 ans : prostatectomie totale sous coelio > 70 ans ou CI à la chir : **radiothérapie externe radicale**
T2 : limitée à la prostate a< 50% lobe, b >50 % lobe, c : deux lobes	
T3 : au-delà de la capsule prostatique a : extra-capsulaire b : vésicules séminales	**Hormonothérapie** : • agonistes LHRH : androcure, décapeptyl : 1inj/semestre à vie • agonistes non stéroïdiens : Eulexine **Radiothérapie**
T4 : Org de voisinage ou tum fixée	**Castration** ⇒ chirurgicale : pulpectomie ou orchidectomie bilat ⇒ chimique : œstrogènes
N1 : gg régional M1 : a : gg non régional, b os, c autre	**Métastases osseuses** : radiothérapie palliative

Comme toujours c'est un petit résumé, il est mieux pour moi, sinon il faut faire attention que la chimiothérapie pas d'intérêt au niveau de cancer du prostate

Kc de la testecule

Cas clinique dans l'épreuve pathologies de 2007, mais sans la classification

1. **ORCHIDECTOMIE PAR VOIE INGUINALE AVEC LIGATURE PREMIERE DU CORDON SPERMATIQUE**
2. **Conservation du sperme au moins 2 prélèvements**
3. **Stadification de la tumeur**

TNM et AJCC à partir de l'analyse histologique, du bilan d'extension et de la valeur des marqueurs postopératoire

		T	N	M	S
Stade 0		pTis	N0	M0	S0, Sx
Stade I		**pT1-4**	**N0**	**M0**	**Sx**
	Stade IA	pT1	N0	M0	S0
	Stade IB	pT2-4	N0	M0	S0
	Stade IS	pT1-4	N0	M0	S1-3
Stade II		**pT1-4**	**N1-3**	**M0**	**Sx**
	Stade IIA	pT1-4	N1	M0	S0-1
	Stade IIB	pT1-4	N2	M0	S0-1
	Stade IIC	pT1-4	N3	M0	S0-1
Stade III		**pT1-4**	**N0-3**	**M1a**	**Sx**
	Stade IIIA	pT1-4	N0-3	M1a	S0-1
	Stade IIIB	pT1-4	N1-3	M0	S2
		pT1-4	N0-3	M1a	S2
	Stade IIIC	pT1-4	N1-3	M0	S3
		pT1-4	N0-3	M1a	S3
		pT1-4	N0-3	M1b	S0-3

T	
Tx	Tumeur primitive ne pouvant être classée
T0	Pas de signe de tumeur primitive
Tis	Néoplasie germinale intratubulaire (carcinome in situ)
T1	Tumeur limitée au testicule et à l'épididyme sans invasion lympho-vasculaire. La tumeur peut atteindre l'albuginée mais pas la vaginale
T2	Tumeur limitée au testicule et à l'épididyme avec invasion lympho-vasculaire ou tumeur atteignant la vaginale
T3	Tumeur étendue au cordon spermatique avec ou sans invasion lymphovasculaire
T4	Tumeur étendue au scrotum avec ou sans invasion lympho-vasculaire
N	
Nx	Pas d'extension ganglionnaire régionale rétropéritonéale
N1	Extension ganglionnaire comportant une adénopathie de moins de 2 cm de plus grand axe ou moins de 5 adénopathies dont aucune ne mesure plus de 2 cm
N2	Extension ganglionnaire comportant une adénopathie de 2 à 5 cm de plus grand axe ou 5 adénopathies dont aucune ne mesure plus de 5 cm ou extension extraganglionnaire histologique
N3	Extension ganglionnaire comportant une adénopathie de plus de 5 cm de grand axe
M	
Mx	Métastase non évaluable
M0	Absence de métastase
M1	Métastase(s) à distance
M1a	Ganglions autres que rétropéritonéaux ou pulmonaires
M1b	Autres sites métastatiques

UROLOGIE

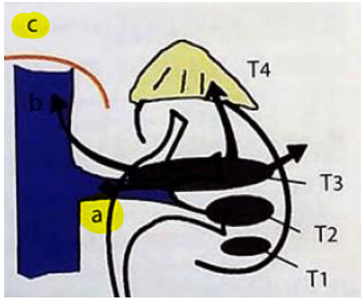
Cancer du rein

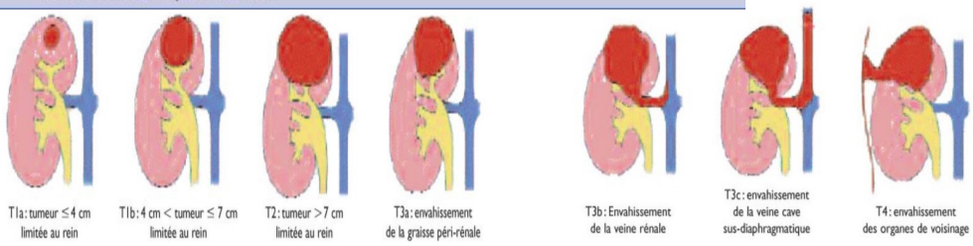
TDM TAP tt les 3-6 mois = evaluation des reponse du TRT

Tableau 1 Classification TNM 2017.	
T – Tumeur	
Tx	Non évaluable
T0	Tumeur primitive non retrouvée
T1	Tumeur ≤ 7 cm, limitée au rein
T1a	≤ 4 cm
T1b	> 4 cm et ≤ 7 cm
T2	Tumeur > 7 cm, limitée au rein
T2a	> 7 cm et ≤ 10 cm
T2b	> 10 cm
T3	Tumeur avec thrombus veineux ou infiltrant le tissu adipeux sans atteinte de la glande surrénale ou du fascia de Gerota homolatéral
T3a	Envahissement du tissu adipeux péri rénal et/ou le tissu adipeux hilaire mais pas le fascia de Gérota et/ou thrombus macroscopique dans la VR ou dans l'une de ses branches (avec présence d'une paroi musculaire)
T3b	Thrombus dans la veine cave inférieure sous diaphragmatique
T3c	Thrombus dans la veine cave inférieure sus diaphragmatique ou infiltration de sa paroi musculaire
T4	Tumeur infiltrant le fascia de Gerota et/ou envahissant par contiguïté la surrénale
N – Métastase ganglionnaire	
Nx	Non évaluable
N0	Pas d'atteinte ganglionnaire métastatique régionale
N1	Atteinte ganglionnaire métastatique régionale
M – Métastase à distance	
Mx	Non évaluable
M0	Pas d'atteinte métastatique à distance
M1	Atteinte métastatique à distance

Classification TNM

T1 : limitée au rein : a ≤ 4, b ≤ 7	N0 : Absence de métastases
T2 : limitée au rein a : > 7 cm b > 10cm	N1 : 1 gg
T3 : extra-rénale	N2 : ≥ 2 gg
a=veine rénale ou graisse **péri-rénale**	
b = VCI sous-diaphrag	
c = VCI sus-diaphragmatique	
T4 = **surrénale ou fascia de Gerota**	M1 : Métastase à distance



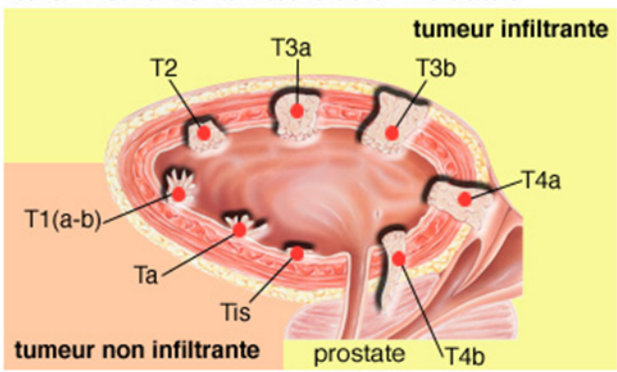


Cancer du la vessie

T	**Tumeur primitive**
T0	Absence de tumeur primitive
Ta	Carcinome papillaire superficiel (respectant la membrane basale)
Cis	Carcinome in situ (plan, respectant la membrane basale)
T1	Carcinome envahissant le chorion sous-muqueux
T2	Carcinome envahissant le muscle
T2a	Carcinome envahissant la partie superficielle du détrusor (moitié interne)
T2b	Carcinome envahissant le muscle profond (moitié externe)
T3	Carcinome envahissant la graisse périvésicale
T3a	Envahissement microscopique
T3b	Envahissement macroscopique
T4	Carcinome envahissant une structure périvésicale
T4a	Prostate, utérus ou vagin
T4b	Paroi abdominale ou pelvienne
N	**Ganglions régionaux**
N0	Absence de métastase ganglionnaire régionale
N1	Ganglion unique < 2 cm
N2	Ganglion unique de 2 à 5 cm ou ganglions multiples, tous < 5 cm
N3	Ganglion(s) > 5 cm
M	**Métastases à distance**
M0	Absence de métastase à distance
M1	Présence de métastases à distance

M+ : métastase (foie, poumon, os)

les tumeurs de la vessie selon le stade



Cancer des VES

VES = Voies Excrétrices Supérieures

T Tumeur primitive
N Ganglions lymphatiques régionaux
M Métastases à distance

- **Tx** Tumeur primitive non évaluable
- **T0** Tumeur primitive non retrouvée
- **Ta** Carcinome papillaire non invasif
- **Tis** Carcinome *in situ*
- **T1** Tumeur envahissant le chorion
- **T2** Tumeur envahissant la musculeuse
- **T3** *Bassinet et calices* : tumeur dépassant la musculeuse envahissant la graisse péri- pyélique ou le parenchyme rénal
- *Uretère* : tumeur dépassant la musculeuse et envahissant la graisse péri- urétérale
- **T4** Tumeur envahissant les organes de voisinage ou la graisse péri- rénale à travers le rein
- **Nx** Ganglions non évaluables
- **N0** Absence de métastase ganglionnaire régionale
- **N1** Métastase ganglionnaire unique 2cm
- **N2** Métastase ganglionnaire unique > 2 cm et 5 cm ou métastase(s) ganglionnaire(s) multiple(s) 5 cm
- **N3** Métastase(s) ganglionnaire(s) > 5 cm

- **Mx** Métastases non évaluable
- **M0** Absence de métastase à distance
- **M1** Métastase(s) à distance

Dr.A.L